SDD 167 Sujet n°1

Spécialité : Pneumologie

Date : 11/11/2023
Auteur : BATTON Romain (DES de médecine interne - Promotion ECN 2019)
Relecteur(s) : VILLARD Sébastien (DES de médecine interne - Promotion ECN 2023), Lucie-Lou Vial (DES MAR, EN 2023/2024)

Domaine d'apprentissage principal	Entretien/interrogatoire
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie diagnostique
Item(s) en lien avec la station	Toux (item 200)
Situation(s) de départ en lien avec la station	Toux
Matériel nécessaire à la station	Aucun
Contexte de la station	Consultation

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes médecin de consultation de pneumologie. Vous recevez Mme Thibaut, âgée de 69 ans, au cabinet qui présente une toux.

Ses paramètres vitaux sont normaux mais elle est très anxieuse. Elle ne présente pas de fièvre le jour de la consultation.

Elle a 3 enfants nés par voie basse.

Le test PCR COVID réalisé avant la consultation est négatif.

Consignes :
Vous avez 8 minutes pour :

- Conduire un interrogatoire orienté
- Évoquer vos hypothèses diagnostiques
- Prescrire les examens complémentaires justifiés

Vous ne devez pas :

- Rédiger d'ordonnance
- Prescrire de traitement

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station avec patient standardisé.

ECOS TACFA
GRILLE D'ÉVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)		
1.	Recherche les antécédents personnels (2 parmi) : - personnels ORL - personnels de RGO - personnels allergiques	1 pt
	Recherche des antécédents pneumologiques et cardiologiques	1 pt
2.	Demande les traitements actuels	0,5 pt
3.	Symptômes de toux - Fièvre associée - Éternuements - Rhinorrhée - Prurit du palais -	1 pt
4.	Symptômes de toux : - Durée de la toux (+ ou - de 3 semaines)	1 pt
5.	Type de toux : - sèche OU avec crachats ?	1 pt
6.	Type de toux : - périodicité : combien de mois par ans	1 pt
7.	Tabagisme (nombre de cigarettes et durée)	1 pt
8.	Signes fonctionnels respiratoire pour un asthme (2 parmi) : toux nocturne ou diurne, sifflements respiratoires, gênantes ou déclenchée lors de l'exercice	1 pt
9.	Signes fonctionnels ORL / rhinorrhée postérieure (1 parmi) : - raclement de gorge, écoulement nasal, obstruction nasale, troubles de l'odorat, anosmie	1 pt
10.	Signes fonctionnels néoplasie sous jacente / tumorale - hémoptysie OU - altération de l'état général	1 pt
11.	Hypothèse médicamenteuse : - prise d'IEC/ARAII (médicaments terminant par "-pril" ou "-sartan")	0,5 pt
12.	Signes fonctionnels pour une maladie de système (1 parmi) : - Sjogren : syndrome sec oculaire ou buccal - Douleurs ou gonflements articulaires - hypothyroïdie - constipation, fatigue, perte de cheveux, teint cireux, toux productive	0,5 pt

13.	Prescription d'une radiographie de thorax (**OBLIGATOIRE**)	2 pts
	Enoncer	
14.	Prescription d'examen paraclinique : EFR - hypothèse à donner si EFR énoncé : BPCO	1 pt
Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)		
1.	**1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair**	

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

2.	**2. APTITUDE À QUESTIONNER**

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

TOTAL (max 20 items)	**points**

<u>Éléments de rétroaction :</u> (facultatif)

Chez un.e patient.e qui fume, la recherche d'un cancer du poumon est primordiale, la radiographie thoracique est obligatoire.

Proposer un sevrage tabagique chez cette patiente qui tousse est primordial (pour le risque de cancer, mais aussi en tant qu'élément diagnostic).

Les examens complémentaires découlent de l'interrogatoire orienté sur les différentes étiologies de toux chronique (pneumologique, cardiologiques, allergiques, digestifs, médicaments, systémiques).

Les signes fonctionnels de la toux servent à éliminer les différentes étiologies dont les 3 principales sont l'asthme, le RGO et la sinusite avec jetage postérieur.
Par exemple, une toux avec des sibilants, parfois nocturne, oriente vers un asthme om il faut dérouler l'interrogatoire du patient asthmatique. La toux peut également être le seul symptôme de RGO, il faut le rechercher systématiquement.
La rhinosinusite avec jetage postérieur peut-être frustre également.

Les imageries comme le scanner des poumons ou des sinus, sont justifiés en seconde intention.

L'item toux est également nécessaire à comprendre pour orienter le patient vers le bon spécialiste par la suite.

ECOS TACFA
SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

La patiente arrive en consultation avec une toux chronique depuis plusieurs semaines, elle est très gênée. Elle tousse pendant la consultation, la nuit mais également lors des efforts.

Le seul élément d'orientation est le tabagisme actif. Il faut tout de même éliminer toutes les autres causes de toux chronique chez cette patiente qui pourrait être atteinte de BPCO (tabagisme prolongé, bronchite chronique hivernale)

Plan de la station ECOS :

Salle de consultation, assise face au médecin

Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :

Bonjour docteur, je viens vous voir en consultation car je suis très gênée, je tousse tout le temps

Identité du patient :

Femme, Madame Thibaut, 69 ans, 1m65, 89 kg (IMC = 31 kg/m2)

Mode de vie :

Retraitée Ancienne vendeuse de livres dans une librairie Vit avec son mari Logement insalubre, literie synthétique 3eme étage avec ascenseur 1 chat au domicile Pas de plantes au domicile Autonome dans les activités de la vie quotidienne Mariée, 3 enfants 2 petits enfants dont 1 de 2 ans Tabagisme actif 3-4 cigarettes par jour depuis 26 ans Pas d'alcool chronique Pas d'allergie

Comportement global :

Logorrhéique, anxiété

Antécédents personnels :

- HTA traitée par antihypertenseurs - Diabète de type 2 non compliqué sous METFORMINE, bien suivie HbA1c 7,4% - Pas d'antécédents d'infarctus ou d'AVC

- Pas d'antécédents pulmonaires personnels ou familiaux
- Pas d'antécédents digestifs
- Accouchements voie basse
- Pas d'allergie

Antécédents familiaux :

Médicaments :

Traitements de fond :
- METFORMINE 1 g matin et soir
- VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE (depuis 30 ans)
- PARACÉTAMOL si besoin

Symptômes positifs :

"Depuis combien de temps dure la toux ? → "c'est pire depuis 6 mois"

"Avez-vous des crachats associés à la toux ? → "oui très souvent surtout l'hiver"

"Couleur des crachats et quantité " → je ne sais pas, je ne regarde pas le mouchoir

Pas de fièvre
Pas d'allergie connue

"combien de mois par an dure la toux ?" → "tout l'hiver et à chaque fois que j'ai un rhume"

si demande la consommation de tabac —> cf mode de vie, pas de cannabis

Signes négatifs :
- répondre négativement si demandés :
  - Signes fonctionnels respiratoire pour un asthme (2 parmis) : toux nocturne ou diurne, sifflements respiratoires, gênantes ou déclenchée lors de l'exercice
  - Signes fonctionnels ORL / rhinorrhée postérieure (1 parmis) : raclement de gorge, écoulement nasal, obstruction nasale, troubles de l'odorat, anosmie
  - Signes fonctionnels néoplasie sous jacente / tumorale : hémoptysie OU

altération de l'état général

- "Avez vous du reflux ou des brûlures épigastriques ?" → "parfois mais c'est très rare"
- "Avez-vous des signes ORL ?" → "je ne pense pas, jamais"

Constantes :

145/89
87 bpm
37.2°C

Donnée complémentaire :

Pas de donnée complémentaire

Questions de relance :

Après 6 min demander si le candidat a terminé son interrogatoire pour lui demander quel examen complémentaire prescrire à l'issue de la consultation (réponse attendue = radiographie thoracique)

ECOS TACFA

FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

Où se positionne le/les patients, étudiant, le matériel

Matériel nécessaire à la station :

- *IPAD pour examinateur*
- *Feuille de brouillon pour candidat*
- *Stylo pour candidat*
- *Feuille de brouillon pour évaluateur*
- *Stylo pour évaluateur*

Documents présents dans la station :

- *Feuilles d'évaluation de papier de secours*